

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар департаментинин
директорунун орун басары
Кысанов Т.А. 
« 26 » Октябрь 2023-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ПАРДИФЕН С

Соодадагы аталышы: Пардифен С.

Эл аралык патенттелбеген аталышы: парацетамол

Дарынын түрү: ректалдык суппозиторийлер

Курамы:

Пардифен С 125 мг: ар бир суппозиторийде төмөнкүлөр камтылат:

Активдүү зат:

Парацетамол (ацетаминофен) USP 125 мг

Көмөкчү зат: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 6000, метилпарабен, пропилпарабен, бутилленген гидрокситолуол, титан диоксиди.

Пардифен С 250 мг: ар бир суппозиторийде төмөнкүлөр камтылат:

Активдүү зат:

Парацетамол (ацетаминофен) USP 250 мг

Көмөкчү заттар: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 6000, метилпарабен, пропилпарабен, бутилленген гидрокситолуол, титан диоксиди.

Сүрөттөмөсү: Ак тунук эмес ок сымал формасындагы суппозиторийлер.

Фармадарылык тобу: Нерв системасынын ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Анальгетиктер. Башка анальгетиктер жана антипиретиктер. Анилиддер. Парацетамол.
АТХ коду: N02BE01.

Фармакологиялык таасири:

Фармакодинамикасы:

Ооруну басуучу жана дене ысыгын төмөндөтүүчү таасир корсетет. Оорунун жана терморегуляциянын борборлоруна таасир берүү менен БНСте циклооксигеназаны бөгөйт. Сизгенүү очогунда клеткалык пероксидазалар циклооксигеназага парацетамолдун таасирин

нейтралдаштырат, бул маанилүү сезгенүүгө каршы таасиринин жоктугун түшүндүрөт. Препарат суулуу-электролиттик алмашууга (натрийдин жана суунун кармалуусуна алып келбейт) жана АИЖ былжыр челине терс таасир көрсөтпөйт.

Фармакокинетикасы:

Ректалдык суппозиторийлердин курамына кирген парацетамол көтөн чучуктун былжырлуу челинде пероралдуу колдонууга караганда жайыраак сиңирилет. Плазмада парацетамолдун эң жогорку концентрациясына 2-3 сааттан кийин жетет. Плазма белоктору менен байланышуусу 20-25% түзөт. Боордо негизинен сульфаттар жана глюкуронаттар менен конъюгаттарды пайда кылуу менен жана, кандайдыр бир деңгээлде, (4% аз) – цистеинди жана меркаптур кислотасын пайда кылып, кычкылдануу жолу менен (цитохрома Р450 катышуусу менен) зат алмашат. Парацетамолдун 80% негизинен метаболиттер түрүндө заара менен бөлүнүп чыгат. Кабыл алынган дозанын 5%га жакыны өзгөрүлбөгөн түрдө бөлүнүп чыгат. Ректалдык суппозиторийлерди колдонгон учурда парацетамолдун жарым жартылай бөлүнүп чыгаруу мезгили 4-5 саатка жакынды түзөт.

Колдонууга көрсөтмө:

Төмөнкүлөр катары колдонулат:

- КРВИ, сасык тумоодо, балдар инфекцияларында, вакцинадан кийинки реакцияларда жана дене табынын жогорулашы менен коштолгон башка абалдарда дене ысыгын төмөндөтүүчү каражат;
- жеңил жана орточо интенсивдүүлүктөгү оору синдромунда, анын ичинде: баш жана тиш оорусунда, булчуң ооруларында, невралгияда, мертинүүлөрдө жана күйүктөрдө ооруну басуучу каражат.

Колдонуу жолу жана дозалары:

Пардифен С ректалдык колдонулат.

Суппозиторийлерде орточо бир жолку дозасы баланын дене салмагына көз каранды жана ар бир 4-6 саатта суткасына 3-4 жолу дене салмагына 10-15 мг/кг түзөт. Эң жогорку суткалык дозасы дене салмагына 60 мг/кг ашпашы керек.

Пардифен С 125 мг:

125 мг суппозиторийлери дене салмагы 8ден 16 кг.га чейинки балдарда колдонулат (адатта 6 айдан 3 жашка чейинки курак).

Дене салмагы 8 ден 16 кг.га чейинки балдарга 1 суппозиторийден (125 мг) суткасына 3-4 жолу 4-6 саатта. Суткасына 4 суппозиторийден ашык колдонууга болбойт.

Пардифен С 250 мг:

250 мг суппозиторийлери дене салмагы 16дан 22 кг.га чейинки балдарга колдонулат (адатта 4 төн 7 жашка чейинки курак).

Дене салмагы 16дан 22 кг.га чейинки балдар үчүн сунушталган дозасы 1 суппозиторийден (250 мг) 4-6 саатта суткасына 3-4 жолу. Суткасына 4 суппозиторийден ашык колдонууга болбойт.

Сунушталган дозасынан ашырылбашы керек. Жогору дозалары ооруну басуучу таасирдин көбөйүшүнө алып келбейт. Киргизүүнүн алдында суппозиторийди сындырбаңыз – бүтүн гана суппозиторийди киргизүү керек.

Айкын бөйрөк алсыздыгы учурунда (креатинин клиренси <10 мл/мин) кабыл алуунун ортосундагы аралык 8 сааттан кем эмести түзүшү керек.

Дарылоонун узактыгы:

Дене ысыгын төмөндөтүүчү катары 3 күн жана ооруну басуучу каражат катары 5 күн.

Дарылык таасиринин жоктугунда дарылоону токтотуп, дарылаган дарыгерге кайрылыңыз.

Каршы көрсөтмө:

- парацетамолго же көмөкчү заттарга жогору сезгичтүүлүк;
- боор же бөйрөк функцияларынын айкын бузулуулары;
- жакын арада болгон сезгенүү же көтөн чучуктан кан агуу (киргизүү жолуна байланышкан каршы көрсөтмө);
- дене салмагы 8 кг.дан аз балдар (125 мг суппозиторийлери үчүн);
- дене салмагы 17 кг.дан аз балдар (250 мг суппозиторийлери үчүн).

Препарат боор жана бөйрөк функцияларынын бузулууларында, Жильбер, Дубин-Джонсон, Ротор синдромунда, кан системасынын ооруларында (аз кандуулук, тромбоцитопения, лейкопения), глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа жетишсиздигинде *этияттуулук менен* колдонулат.

Кыйыр таасирлери:

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: окшуу, кусуу, ичтин оорусу мүмкүн.

Аллергиялык реакциялар: териде жана былжыр челдеринде бөртмө, кычышуу, бөрү жатыш, Квинке шишимиги.

Кан жаратуу системасы тарабынан: сейрек — аз кандуулук, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз.

Жогору дозаларда узакка колдонууда гепатотоксиндүү жана нефротоксиндүү (чарымдуу нефрит жана папиллярдык некроз) таасири, гемолитикалык аз кандуулук, апластикалык аз кандуулук, метгемоглобинемия, панцитопениянын өрчүүсү мүмкүн.

Ашыкча доза:

Симптомдору: биринчи 24 саатта кубаруу, окшуу, кусуу жана ич жактын оорусу; 12 сааттан кийин боор алсыздыгынын өрчүүсү менен бөйрөктүн жана боордун жабыркоосу (энцефалопатия, кома, өлүмгө учуроо), жүрөк аритмиялары жана панкреатит.

Дарылоо: метионинди ичүүгө же N-ацетилцистеинди тамыр ичине куюну дайындоо.

Кийинки дарылоочу чараларды (кийин дагы метионинди ичүү, N-ацетилцистеинди тамыр ичине куюу) жүргүзүү зарылдыгы канда парацетамолдун концентрациясына, ошондой эле аны ичкенден кийинки убакыттын өтүшүнө жараша аныкталат.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири:

Урикозуриттик ДКнын таасирин төмөндөтөт. Парацетамолду жогору дозаларда коштоп колдонуу антикоагулянттык ДК таасирин жогорулатат (боордо прокоагулянттык факторлордун синтезин төмөндөтүү). Боордо микросомалдык кычкылдануунун индукторлору (фенитоин, этанол, барбитураттар, рифампицин, фенилбутазон, трициклиттик антидепрессанттар), этанол жана гепатотоксиндүү ДК гидроксилденген активдүү метаболиттердин продукциясын көбөйтөт, бул чоң эмес дозасынан ашырууда да оор уулануунун өрчүү мүмкүндүгүн шарттайт. Барбитураттарды узакка колдонуу парацетамолдун таасирин төмөндөтөт. Этанол курч панкреатиттин өрчүүсүнө түрткү берет. Микросомалдык кычкылдануунун басаңдаткычтары (анын ичинде циметидин) гепатотоксиндүү таасири коркунучун төмөндөтөт. Парацетамолду жана башка ССКК бирге узакка колдонуу «анальгетикалык» нефропатиянын жана бөйрөк папиллярдык некрозу, бөйрөк алсыздыгынын терминалдык баскычынын башталышынын өрчүү коркунучун жогорулатат.

Жогору дозаларда парацетамолду жана салицилаттарды бир убакта узакка дайындоо бөйрөктүн же табарсыктын залалдуу шишигинин өрчүү коркунучун жогорулатат. Дифлунисал парацетамолдун плазмалык концентрациясын 50% - гепатотоксиндүүлүктүн өрчүү коркунучун жогорулатат. Миелотоксиндүү ДК препараттын гепатотоксиндүү

көрүнүштөрүн күчөтөт.

Өзгөчө көрсөтмө:

Парацетамолду 3 күндөн ашык жана оору синдромунда 5 күндөн ашык колдонуу маалында узакка созулган калтыратма синдромунда дарыгердин кеңеши талап кылынат. Плазмада глюкозаны жана заара кислотасын сандык аныктоодо лабораториялык изилдөөнүн көрсөткүчтөрүн бурмалайт. Узакка дарылоо мезгилинде четки кандын көрүнүшү жана боордун функционалдык абалын көзөмөлдөө зарыл.

Пардифен С препаратын башка парацетамол камтыган препараттар менен бир убакта колдонуудан алыс болуу керек, себеби бул парацетамолдун дозасынан ашыруусун пайда кылышы мүмкүн.

Чыгаруу формасы:

Пардифен С 125 мг же 250 мг:

ПВХ/ПЭ жасалган стрипте 5 суппозиторийден.

2 стрип медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Рецепти жок.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

VEGAPHARM LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,
London, England, SE10 9QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

BLISS GVS PHARMA LTD.

Plot No. 10, 11-A, 12, Survey No. 38/1,

Dewan Udyog Nagar, Aliyali Village, Taluka Palghar,

Thane 401404, Maharashtra State, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Шооруков көчөсү, 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com